

医伴 第三版方案：对话为主

主界面只有一个对话框。患者只做两件事：不舒服时跟它说，看完医生把医嘱拍给它。其余的都在后台自动完成。

2026 年 10 月 3 日 · 主管整理 · 依据：inbox/redesign-chat-first.md（你的原话和功能说明）、对接员转来的四个回答、现有代码

一页看懂

- **界面只剩三处**：一个对话（主界面）、一页「我的资料」、角落里一个红色的「应急」按钮。电脑上显示成一部手机，只在手机里操作；真手机上全屏。
- **患者只做两件事**：不舒服时说一句；看完医生拍一张医嘱。默认按住说话，可以切到打字，可以拍照。
- **后台自动判断你要干什么**：是说不舒服、是在提问、是传了医嘱，还是报了一个血糖数。患者不用找功能，也不用知道有哪些功能。
- **现有的能力都留着，只是不再是一个个页面**：追问、给医生的一页、医嘱存档、问答、提醒、健康指标、应急手册，全部变成对话里的一步，需要时才出现。
- **安全的做法不变**：危险信号由写死的规则判断；给医生看的内容只由记录生成；AI 写的每一句都要过滤。新增的是「初步分诊」：要不要看医生、多急、挂哪科。
- **工作量**：大约 13 到 16 个小时的并行开发，分三段，每段结束都有能看的东西。见第 9 节。
- **需要你定 12 件事**，每件我都给了选项和建议，见第 10 节。最要紧的是第 1 件：分诊说到什么程度。

目录

1. 我对你想法的理解
2. 要解决的问题
3. 解决办法总览
4. 界面示意：六张图
5. 每一步流程
6. 前端怎么做
7. 后端怎么做
8. 和现在的版本相比
9. 工作量和顺序
10. 需要你拍板的 12 件事
11. AI 能做什么、不能做什么

1 我对你想法的理解

下面是我读完你的原话和功能说明之后的理解。哪一条理解错了，请直接指出来，方案跟着改。

你说的	我的理解
「主界面就是一个直接说，然后 AI 就可以直接给你回」「有点像豆包」「默认还是语音输入，我可以切换打字」「可以上传照片」	打开就是对话。输入栏上最大的是「按住说话」，旁边可以切到键盘、可以拍照或从相册选。AI 的回复直接出现在对话里。
「下面你可以选择一些，比如去看医生、讲解病史、导出」	输入栏上方有三个快捷选项。它们是「捷径」，不是必经之路：不点它们，直接说「我要去看医生了」也一样。
「再有一个界面可以查看患者的详细信息」	第二个界面「我的资料」：个人信息、就诊记录、提醒、血糖血压。平时不用进，想看的时候才进。
「患者不需要知道所有功能，但是他需要的时候这个功能要有，就像特斯拉或者车一样」「应急功能一定要有，但是不能很复杂」	功能都在，但不摆出来。日常只有对话；后台看情况把需要的那一步递到患者面前。应急是例外：它像车上的应急按钮，固定在角落，任何时候一点就开。
「患者唯一需要做的就是不舒服跟 AI 说，然后拿完医生信息后上传」「所有的都是后端，他会自动，不需要患者一个一个去理解」	这是整个方案的核心。整理、归档、关联以前的记录、设提醒、准备复诊要说的话，都是后台的事。
「我一问我就知道我什么病」	按你回给对接员的话：做初步分诊，结合历史记录判断要不要看医生，不给过多医疗建议。说不说可能的病，我列成了选项请你定（第 10 节第 1 件）。
「我一问我就知道这能不能吃」	食物和药都算。结合过敏、基础病、医生的医嘱来回答；不替人定剂量。
功能说明第 1 部分：问诊	患者说哪里不舒服，AI 把缺的信息问出来（八类），疼痛用身体图定位，口语词确认成规范说法，和以前的记录有关联时追问，最后生成一段病情描述，不满意可以改。
功能说明第 2 部分：医嘱	上传医嘱照片，提取药物、注意事项、诊断、时间地点、其他治疗、复诊时间；展示给患者；然后二选一：a 整理待办并设提醒（频率可选），b 解释。复诊前帮着准备要说的话；之后出现副作用可以接着记。
「离开页面弹出提示问保存还是放弃」	每次问诊或医嘱都是一条就诊记录，可以只有问诊、只有医嘱，或者两者都有。结束时让患者选保存还是放弃。
注册：年龄、性别、学历、基础病、家族遗传病	填表为主，基础病可以先跳过。体检报告是可选的，随时可以拍来补全。
「做成手机版，有一个手机造型，像虚拟机那种」	电脑浏览器里显示一部手机的外形，应用只在这部「手机」里运行。

有两个词我拿不准，先按下面的理解做，并列进了第 10 节请你确认：

- 「讲解病史」：我理解为两种都要。一是把我的病史整理成医生看得懂的一段话，讲给医生；二是用大白话把诊断和医嘱讲给我自己听。
- 「导出」：我理解为把给医生的那一页、或者全部就诊记录，存成 PDF、打印，或复制成文字。

2 要解决的问题

说不清

不知道怎么描述病情。说了口语，医生要再翻译一遍；轻的症状觉得不重要，就不说了。

记不住

什么时候开始的、以前得过什么、医生上次怎么说的、药怎么吃、哪天复诊。

效率低

医生要从头问一遍。患者回家后医嘱没人盯，下次复诊又从头说。

这三个问题来自最早的项目概述，没有变。第三版要多解决一个：

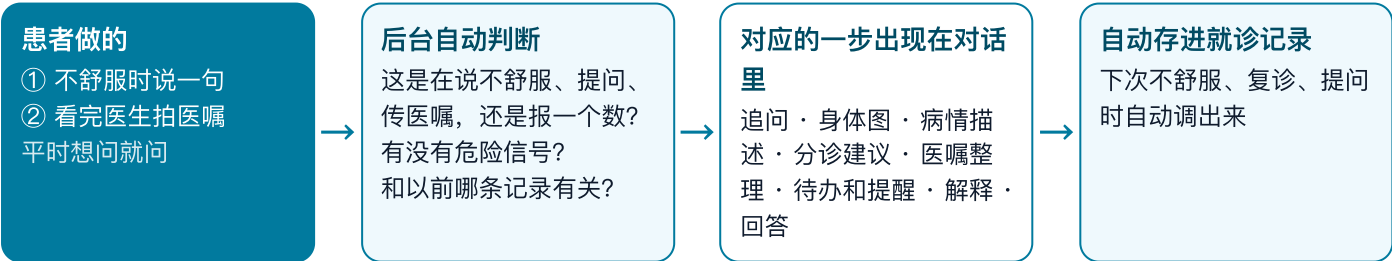
第四个问题：现在的产品还是太复杂。第二版把功能做成了一一个个入口：首页的卡片、去看医生、问医生、应急手册、看完医生了、我的档案、长期管理。每一个单看都不难，但患者要先弄明白「我现在该点哪个」。这本身就是负担，对老人尤其是。

第三版怎么回应这四个问题

问题	第三版的做法
说不清	AI 把缺的问出来（八类信息）；疼在哪里用图点；口语词确认成医生的说法；和以前的记录有关联时主动追问；最后替患者写成一段病情描述。
记不住	说过的、拍过的都自动归进就诊记录；医嘱变成待办和提醒；记不清的直接问（上次医生说了什么、这个药怎么吃、这个能不能吃）。
效率低	去看医生前一键生成给医生的一页；复诊前自动准备「这次要说什么」；医嘱拍照就存档，不用手打。
太复杂	只有一个对话。患者不选功能，后台判断。应急单独留一个按钮。

3 解决办法总览

一句话：患者只管说和拍，后台负责听懂、分流、整理、归档、提醒。



像车一样分三层

层	车上的对应	医伴里是什么
天天用的	方向盘、油门	对话框：说话、打字、拍照。
自动的	发动机、变速箱、各种传感器	听懂意图、追问、整理、关联以前的记录、分诊、归档、提醒、每天问一句怎么样了。患者看不见，也不用懂。
应急的	双闪、SOS 按钮	右上角红色的「应急」：给身边的人看的应急卡和一键拨打 120。对话里一旦出现危险信号，也会立刻给出红色提示。

患者说一句话之后，后台可能走的六条路

患者说的或做的	后台认成	接下来发生什么
「这两天右膝盖疼」	说不舒服	进入问诊：追问缺的信息，疼痛给身体图，最后出病情描述和分诊建议，存成一条就诊记录。
拍了一张医嘱或处方	传医嘱	认出诊断、药、注意事项、其他治疗、时间地点、复诊时间；展示给患者；问要「整理待办并提醒」还是「解释」。
「这个药能和酒一起吗」 「虾能不能吃」「上次医生说了什么」	提问	查档案、过敏、医嘱和以前的记录来回答，并指出依据是哪条记录。
「今天空腹血糖 6.5」	报一个数	记下来；太高或太低时按规则立刻提醒，并跟进复测。
「我明天去医院」或点 「去看医生」	要去看医生	把这次的情况和相关的以前记录整理成给医生的一页，可以直接给医生看，也可以导出。
「胸口很闷，喘不上气」	危险信号	不等 AI：规则立刻给出红色提示和「拨打 120」按钮。

认不准的时候不猜：AI 会问一句「你是想……还是……？」。认错了，患者说一句「不是，我是想问……」就改过来。

界面只有三处

① 对话（主界面）

打开就是它。上面是对话，下面是三个快捷选项和输入栏。左上角进「我的资料」，右上角是「应急」。

② 我的资料

个人信息、就诊记录、提醒、血糖血压、设置。可以自己补充以前的病史。

③ 应急

固定在右上角的红色按钮。点开是应急卡：我是谁、有什么病、对什么过敏、联系人、晕倒怎么做，还有拨打 120。

4 界面示意：六张图

示意图，说明每一步长什么样。电脑上整个应用显示在这样一部手机里，真手机上全屏。

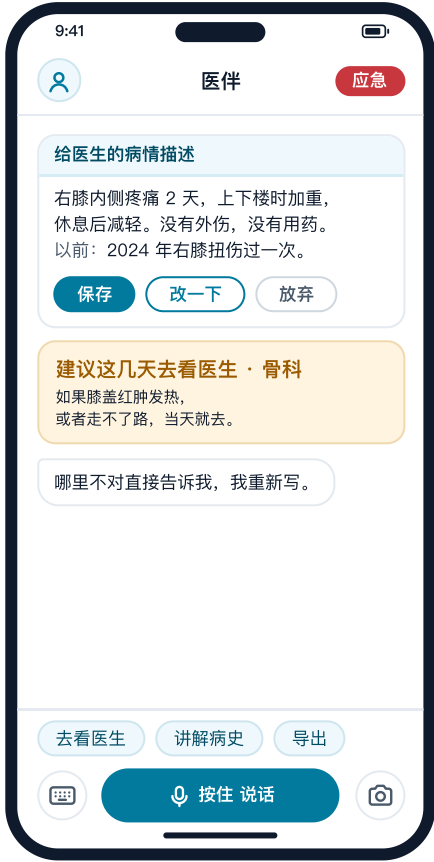
① 主界面



② 问诊：追问和身体图



③ 病情描述和分诊



④ 看完医生：拍医嘱



⑤ 提醒怎么设



⑥ 我的资料



5 每一步流程

5.1 第一次打开：注册

- 一张表，五项：年龄、性别、学历、基础病、家族遗传病。基础病可以点「以后再填」。
- 表的下面有一行「有体检报告？拍一下，我帮你填」。这是可选的，以后在对话里随时拍也行。现有的体检报告识别直接用。
- 学历只用来决定 AI 解释时用词的深浅，不会出现在给医生的内容里。
- 填完直接进对话。AI 说一句它能做什么，不做功能介绍。

5.2 不舒服时：问诊

患者说一句哪里不舒服。AI 只问缺的，一次一个问题，能点选的就给选项，可以回答「不清楚」跳过。

要问清的八类	怎么问	什么时候不问
部位	疼痛类弹出身体图，点一下最疼的地方；膝、肩、腰背、腹部有放大的细分图。	患者已经说得很具体，或者不是疼痛类的不舒服（比如失眠）。
疼痛方式	给几个可以点的说法：酸胀、刺痛、绞痛、烧灼感、一动就疼、说不清。	不是疼痛。
持续时间	「什么时候开始的？」	第一句话里已经说了。
什么时候会不舒服、特定情境	「什么时候更明显？比如饭后、夜里、活动时。」	已经说了诱因。
伴随症状	按部位给两三个最相关的，可以多选；另有「没有别的」。	已经说了。
接触的药物	「吃过或用过什么药吗？」	已经说了，或者明确说没吃。
病史	不让患者从头讲：档案和以前的就诊记录里有的，直接带进描述；只对有关联的问一句确认。	没有相关记录。
有多难受	有点难受、比较难受、非常难受，三选一。	已经说了。

口语变成医生的说法

患者说「扭着疼」，AI 确认：「是一阵一阵拧着的那种疼吗？医生管这个叫绞痛。」患者点「是」。病情描述里写「绞痛（患者原话：扭着疼）」，两种说法都留着。

常见的口语词有一张对照表，写在代码里；表里没有的由 AI 提出规范说法，同样要患者确认后才写进去。

和以前的记录有关联时追问

档案里有糖尿病，这次说脚麻；或者三个月前看过胃炎，这次又是上腹痛。AI 会问一句：「你三个月前看过急性胃炎，这次和那次像吗？」

目的是不漏掉患者觉得不重要的信息。AI 只是问，不下结论。慢性病患者的问诊会把以前的报告和指标自动整合进来。

问完之后

- 1. 生成病情描述。一段给医生看的话，放在一张卡片里。患者不满意，直接说「不对，是饭后才疼」或「再加一句我对青霉素过敏」，AI 重新写。
- 2. 给出分诊建议。要不要看医生、多急、挂哪个科、去之前留意什么。有危险信号时直接是红色提示。说到什么程度见第 10 节第 1 件。
- 3. 保存或放弃。卡片上有「保存」「改一下」「放弃」。保存后成为一条就诊记录。
- 4. 之后每天问一句。AI 在对话里主动问「昨天说的膝盖疼，今天怎么样了？」，患者点「好多了、差不多、更严重了」之一，或者说直接说。

5.3 去看医生

- 点「去看医生」，或者说「我明天去医院」。有正在记的不舒服，就用它；没有，就先走一遍 5.2 的问诊。
- 生成给医生的一页：最上面是大字的几行要点，下面是病情描述、时间线、相关的以前记录、过敏和在吃的药、可以问医生的问题。
- 这一页可以全屏直接给医生看，也可以导出成 PDF、打印，或复制成文字。

5.4 看完医生：医嘱

- 1. 拍照上传。病历、处方、医嘱单、药盒都行，可以拍几张。照片只用来认字，认完就丢。也可以说一遍或打字。
- 2. 后台提取六类信息：有哪些药和怎么吃、要注意的事项、诊断、时间和地点、其他治疗措施（比如锻炼哪里、制动）、复诊时间（有就提取）。认不准的地方会标出来。
- 3. 展示给患者确认。不对的地方直接说，AI 改。
- 4. 二选一，也可以都选：
 - a 整理要做的事并提醒。AI 列出待办：吃药、其他治疗、复诊。患者选哪些要提醒、多久提醒一次，然后一键设好。
 - b 给我解释一下。AI 列出可以解释的部分：诊断是什么意思、每个药是干什么的、常见的副作用、注意事项为什么要注意。患者点哪个讲哪个，也可以直接问。
- 5. 自动归档。如果之前有对应的问诊，医嘱并进同一条就诊记录；没有，就单独成一条。
- 6. 之后。出现副作用或新的变化，直接在对话里说，会记进这条记录。有复诊的，到时间前 AI 帮着准备「这次复诊可以说什么」：这段时间的变化、药吃得怎么样、有没有副作用、想问的问题。

5.5 平时提问

问的是	怎么回答
记不清的事	「上次医生说了什么」「什么时候复诊」「我对什么过敏」：直接按记录原文回答，不经过 AI 改写，一个字都不会错。
能不能吃（食物）	先查过敏和医嘱里的忌口，有就明确说不能，并指出是哪条记录；再看基础病给一般性的提醒（比如糖尿病和甜食）；都没有就说记录里没有相关限制。
能不能吃（药）、药怎么吃	先复述医生怎么开的；再讲说明书上的一般用法和常见注意事项；涉及两种药能不能一起吃、要不要加量减量，一律请他问医生或药师。不替人定剂量。
这是什么病、严不严重	医生已经下过诊断的，讲这个诊断是什么意思；还没看医生的，走分诊，不猜病名（除非你在第 10 节选了别的选项）。

5.6 紧急情况

- 对话里出现危险信号（胸痛伴喘不上气、神志不清、一侧手脚无力、呕血黑便、血糖过低等），由规则立刻给出红色提示和「拨打 120」按钮，不等 AI。
- 右上角的「应急」随时可以点：应急卡按档案自动生成，给身边的人看。现有的应急手册直接用。

5.7 我的资料和就诊记录

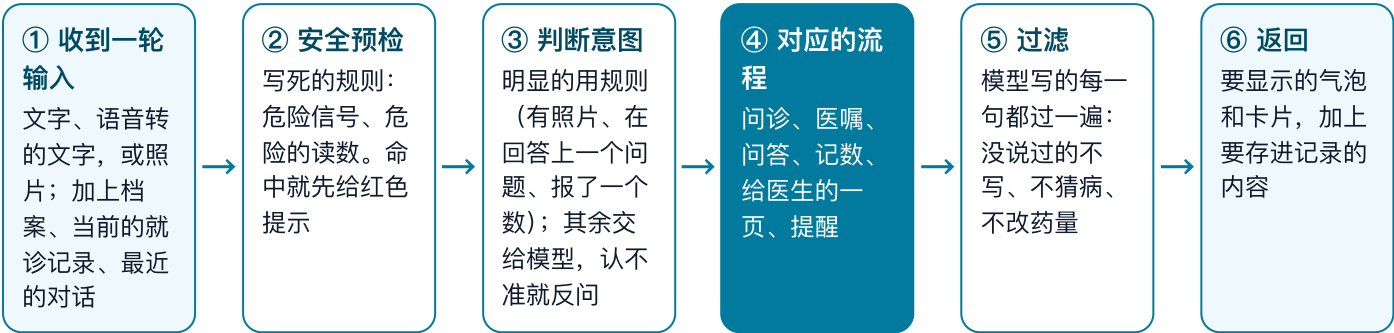
- 一条就诊记录可以是完整的（问诊加医嘱），也可以只有问诊或只有医嘱。后续的追问、副作用、复诊都接在同一条下面。
- 患者可以自己补充以前的病史，问诊时会用到。
- 中途离开：没写完的问诊自动存成草稿，下次打开时 AI 先问「上次说到一半，接着说还是放弃？」。

6 前端怎么做

部分	做法
技术	不换：Next.js 16、TypeScript、Tailwind 4，本地 <code>npm run dev</code> 运行。现有的界面组件、语音和拍照的代码继续用。
手机外形	最外层加一个「手机壳」：屏幕宽度大于手机时，页面中央显示一部手机（约 390 × 844），应用只在里面运行和滚动；真手机上自动全屏，不显示外壳。这是一层外观，不影响里面的代码。
页面	从现在的十几个页面减到四个：对话（/）、我的资料（/me）、应急（/sos）、给医生的一页（/doctor/...，用于全屏展示和导出）。注册是对话前的一屏。
对话	一条连续的对话。消息有两种：普通的文字气泡，和「卡片」。卡片是带按钮的结构化内容，每一种对应后台的一步：可点的回答、身体图、病情描述、分诊建议、医嘱整理、待办和提醒设置、解释选项、记数反馈、红色警报、指向某条记录的链接。
输入栏	中间是大的「按住说话」，松手就发；说的话先变成文字显示在自己的气泡里，认错了可以点气泡改。左边切到键盘，右边拍照或从相册选。现有的录音、切段、语音转文字、图片压缩都直接用。
快捷选项	输入栏上方三个：去看医生、讲解病史、导出。它们只是替患者说一句话，走的是和打字一样的路。
身体图	用矢量图画：全身正面和背面各一张，分成约 30 个可以点的区域；膝、肩、腰背、腹部各有一张放大的细分图。点了之后得到规范的部位名称（比如「右膝内侧」）。
数据	仍然只存在这台设备的浏览器里（之前定的）。结构调整为：档案、就诊记录（问诊、医嘱、后续）、对话、提醒、指标读数。旧数据自动迁移。新增「导出全部资料」做备份。
提醒	应用开着时在对话里提醒，并发浏览器通知。另外给每条提醒一个「加进手机日历」的按钮，网页关着也能响。见第 10 节第 4 件。
字和按钮	沿用现在的规矩：正文不小于 17 像素，可点的地方不小于 48 像素，不用小灰字，不出现技术词。

7 后端怎么做

现在后端是按功能分的七八个接口，由页面决定调哪个。第三版加一个「总调度」：页面只把患者这一轮说的话或拍的照片交给它，由它决定走哪条路。



模块	做什么	现有代码能用多少
意图判断	把一轮输入分到六条路之一；认不准时生成一句反问。	新做。
问诊	从患者的话里提取八类信息；决定下一个问什么（顺序由规则定，措辞由模型写）；口语对照；关联以前的记录；生成和修改病情描述。	约一半：追问上限、不重复提问、从话里读开始时间和轻重、找相似记录，都有了。八类信息、身体图、口语对照、修改重写是新的。
分诊	要不要看、多急、挂哪科。危险信号和加重的判断由规则定，模型只负责措辞和科室。	规则已有（危险信号、发烧、加重、拖了几天）。科室和分诊卡片是新的。
医嘱	认照片或听口述，提取六类信息；生成待办；生成解释。	提取已有（文字和照片都能用）。待办、提醒频率、解释是新的。
问答	查记录回答；能不能吃；药怎么吃。	大部分已有：问医伴的规则直答、带出处、剂量和猜病名的过滤，都做好并测过。「能不能吃」是新的。
给医生的一页	要点和时间线只由记录按规则生成；细节由模型写并过滤。	已有，直接用。
提醒和每天追问	到时间在对话里发一条消息；记录回答。	每天追问已有。吃药和其他待办的提醒是新的。
语音和照片	语音转文字；照片识别。	已有，直接用。

用的模型

不变：智谱 GLM。对话和整理用 glm-5，认照片用 glm-4.6v，语音用 glm-asr-2512。Key 只放在服务端。没有 Key 或接口失败时，内置的规则顶上，演示不会挂。

怎么保证不乱说

三层：规则先于模型（危险信号、该不该催就医）；记录先于文采（给医生的要点只按记录生成，查记录的问题按原文回答）；模型的每句话都过滤。每一条约束都写成代码和测试，现在有 1114 项自动检查，第三版继续加。

一轮对话最多调用模型两次（判断意图一次，执行一次），大多数情况一次：明显的意图由规则判断。预计每轮回复 2 到 4 秒；认照片 20 到 40 秒，期间显示「正在认字」。

8 和现在的版本相比

	内容
保留，直接用	危险信号和各种判断规则；从话里读时间、轻重、体温、血糖血压；找相似的以前记录；给医生的一页（要点、时间线、细节、导出）；医嘱的文字和照片识别；体检报告识别；问答的规则直答、带出处和全部过滤；应急手册的全部内容；血糖血压的规则、提醒和趋势；语音和拍照；李明和王秀兰两套演示数据；全部自动检查。
改造	每天的追问：从首页卡片改成对话里的一条消息。 问诊伴：不再是单独一页，就是主对话。 看完医生：从单独一页改成对话里拍照，之后多了待办提醒和解释两个选项。 健康指标：不再有首页卡片，改成在对话里报数，趋势图放进「我的资料」。 年度摘要：并进「去看医生」，慢病用户生成的那一页自动带上这一年的变化。 建档：从体检报告为主改回填表为主，多了学历和家族遗传病；体检报告变成可选。 我的档案：改名「我的资料」，就诊记录按「问诊加医嘱」重新组织。
砍掉的页面	首页的各种卡片和入口、去看医生页、问诊伴页、看完医生页、症状对话页和详情页、长期管理开关、顶部导航的两个标签。 功能都还在，只是不再是页面。
新做	手机外形；对话主界面和各种卡片；后端总调度和意图判断；八类信息的问诊；身体图；口语对照和确认；病情描述的修改重写；分诊卡片；医嘱之后的待办、提醒频率和解释；复诊前的准备；「能不能吃」；保存还是放弃和草稿；注册表单；导出全部资料。
先放一放	中英文切换：界面文字的英文版已经做了一部分，第三版先只把中文做好；英文的对话需要一整套英文的安全过滤，等主线稳定后再做。见第 10 节第 9 件。

现在手上有两个版本，请知道：3000 端口是你们上午看的冻结版；3200 端口是加了英文界面的版本，还没有换过去。第三版会从 3200 的代码接着改。另外，这两个版本里都有一个今天查出来的安全漏洞（慢病用户在首页记高血糖时，「立即就医」的提示不出现）。第三版重做首页后它会消失；在那之前要不要先花 15 分钟修掉，请你定（第 10 节第 11 件）。

9 工作量和顺序

按今天的做法：我拆任务、分给多个员工并行做、逐个验收。下面是估计，不是承诺；每一段结束我都会在浏览器里走一遍再交给你看。

阶段	时间	做什么	结束时你能看到
第一段：主线	5 到 6 小时	手机外形；对话界面和卡片的框架；输入栏（语音默认、打字、拍照）；后端总调度和意图判断；问诊（追问、口语对照、关联追问、病情描述、分诊）；给医生的一页接进对话；拍医嘱并整理；注册表单。	在手机外形里：说一句不舒服，被追问，拿到病情描述和分诊；拍医嘱，看到整理结果。
第二段：补全	5 到 6 小时	身体图；待办、提醒频率和加进日历；解释；能不能吃；我的资料和就诊记录；导出；每天追问和报数进对话；应急按钮；保存还是放弃和草稿；旧数据迁移；两套演示数据改成新结构。	功能说明里的每一条都能走通。
第三段：检验	3 到 4 小时	规则和过滤的自动检查；用真实模型成批提问找漏洞；两轮模拟用户（一位慢病老人、一位普通感冒的年轻人）实际试用；按发现的问题修。	一份试用报告：每个任务点了几下、哪里卡住、修了什么。

合计约 13 到 16 小时，中间需要你看两次。如果只要最快能演示的，第一段做完就可以给团队看。

主要的风险

风险	怎么应对
后台认错患者的意图	明显的情况用规则判断；认不准就反问；认错了患者说一句就能改；每次分流都记日志，用模拟用户专门测。
只有一个对话框，患者不知道能做什么	三个快捷选项；AI 在合适的时候主动递下一步（「要不要我整理成给医生看的一页？」）；第一次打开时用两句话说清楚两件事。
语音认错字，尤其是药名	说的话先显示成文字，可以改；药名和诊断以医嘱照片为准。
AI 说了不该说的	沿用三层做法，新功能（分诊、解释、能不能吃）各自加过滤和测试。
提醒收不到	网页关着时浏览器通知不可靠，所以加「加进手机日历」。

10 需要你拍板的 12 件事

回复对接员时写「1A 2A 3B」这样就行。绿色的是我的建议。

1 分诊说到什么程度？（最要紧）

- A **只分诊**：要不要看医生、多急、挂哪个科、去之前留意什么。不提任何病名。这最接近你回给对接员的那句话。（建议）
- B 分诊加方向：再加一句「这类情况多半是哪一方面的问题」，比如「肠胃方面」，不说具体病名，并写明要医生判断。
- C 分诊加可能的病名：列出一两个可能的病，写明不是诊断。这最接近「一问就知道我什么病」。风险：说错会耽误人或者吓到人；现有的过滤都是按「不说病名」做的，要重做一遍并重新测。

2 「讲解病史」是讲给谁？

- A **两种都要**：点了以后先问「讲给医生，还是讲给你自己」。（建议）
- B 只讲给医生：把病史整理成医生看得懂的一段。
- C 只讲给自己：用大白话解释诊断和医嘱。

3 解释医嘱（b 选项）讲到多深？

- A **讲明白**：诊断是什么意思、每个药是干什么的、常见副作用和注意事项，按一般的科普和说明书来，并写明以医生为准。不评价医生的方案，不建议换药或改量，剂量数字只复述医嘱。（建议）
- B 更保守：只把医嘱换成大白话，不补充任何额外的知识。

4 提醒怎么送到？

- A **对话里提醒，加日历**：应用开着时在对话里提醒并发浏览器通知；另外每条提醒可以一键加进手机日历，网页关着也能响。（建议）
- B 只在对话里提醒：不做日历。网页关着时收不到。
- C 真正的推送：做成可以安装的应用，需要服务器，工作量大，建议往后放。

5 保存还是放弃怎么做？

- A **自动存草稿**：问诊结束时在卡片上选保存或放弃；中途离开，下次回来 AI 先问接着说还是放弃。（建议）
- B 离开页面时弹窗问：手机浏览器经常不弹这种窗，不可靠。

6 身体图做多细？

- A **全身加四张细分图**：全身正反面，加膝、肩、腰背、腹部。（建议）
- B 只做全身。
- C 再加手、脚、头面部：往后放。

7 注册要不要称呼？你列的五项里没有姓名。

- A **加一项「怎么称呼你」**：可以不填；填了会显示在给医生的一页上。（建议）
- B 不要。

8 学历怎么用？

- A 只用来调整解释的深浅：不给医生看。（建议）
- B 也给医生看：显示在资料和给医生的一页里。

9 中英文切换怎么办？

- A 第三版先只做中文：等主线稳定后再做英文，届时连对话和安全过滤一起做。（建议）
- B 固定文字同时做英文：AI 仍然说中文。

10 手机外形在哪显示？

- A 电脑上显示手机外形，真手机上全屏。（建议）
- B 真手机上也套一层外形。

11 那个安全漏洞什么时候修？

- A 现在就修：约 15 分钟，3000 和 3200 都修。（建议）
- B 不单独修：等第三版把首页换掉。

12 现有的两个版本怎么处理？

- A 3000 保留到第三版第一段做完；3200 的英文界面版不再换过去，第三版从它的代码接着改。（建议）
- B 先把 3200 换到 3000，再开始第三版。

还有一件只能由你本人做的事：第三版改了项目规则文件 CLAUDE.md 里好几条「已定决策」：导航只有两个入口、首页同一时间只突出一件事、AI 不给用药信息、界面全部中文，以及这次新加的分诊。我不会因为转达的消息去改那份文件。批准方案后，请在主管的终端里直接说一句「同意按第三版改 CLAUDE.md」，或者你自己改。

11 AI 能做什么、不能做什么

能做

- 把患者说的话整理成医生看得懂的病情描述。
- 追问缺的信息；把口语确认成规范说法。
- 结合以前的记录提醒：这次和哪次像，有什么要告诉医生。
- 初步分诊：要不要看医生、多急、挂哪科。
- 把医嘱整理成待办并提醒。
- 复述医生开的药和用法；讲说明书上的一般用法、常见副作用和注意事项。
- 回答「能不能吃」：依据过敏、医嘱和基础病。
- 危险信号出现时，直接让人就医或拨打 120。

不做

- 不下诊断。说不说可能的病名，由你在第 10 节第 1 件里定；没有定之前按不说来做。
- 不替人定剂量，不建议加量、减量、停药、换药。
- 不评价医生的方案。
- 不写患者没说过的话：没说过有没有发烧，就不写「无发热」。
- 不编记录里没有的日期、数值、药名。
- 不保存照片和录音，只保存整理出的文字。
- 危险信号的判断不交给模型。

现在的状态（写这份方案时）

- 代码没有动。所有员工都停着，等你批准。
- <http://localhost:3000> 是上午的冻结版；<http://localhost:3200> 是英文界面版。两个都能打开。
- 分享给队友的公网链接没有开：那一步被我这边的权限系统拦下了，需要你本人来做或放行，办法写在 HUMAN_TODO.md 第一条。

这份方案的源文件：[docs/第三版方案-对话为主.html](#)。要改哪句，告诉对接员。